

Ihr autistischer Angehöriger / Ihre autistische Angehörige in stationärer / hoch-unterstützter Pflege

Für Familie und Angehörige — für eine autistische Person in **unterstützter / stationärer / hoch-unterstützter Pflege** eintreten (jedes Alter).

Die Kernidee

Autismus bedeutet über den **Monotropismus**, dass sich die Aufmerksamkeit Ihres Angehörigen in wenige tiefe, intensive „Tunnel“ einschließt. Pflege-Settings sind oft die **schwersten Umwelten überhaupt**: sensorisch feindselig, routine-störend, voller unvorhersehbarer Berührung und Anforderung. Viele in hoch-unterstützter Pflege kommunizieren ohne Sprache und registrieren oder melden Schmerz vielleicht erst, wenn schwer. Ihre Rolle als Familie ist mächtig: Sie sind ihr **Gedächtnis, ihre Anwältin/ihr Anwalt und Kontinuität** — schützen Sie ihre Routinen, Objekte und Interessen, achten Sie auf unerfüllten Bedarf und bestehen Sie darauf, dass sie als Person mit Handlungsfähigkeit behandelt wird, niemals als ein „Verhalten“, das zu managen wäre.

Was Sie beobachten könnten — und was wirklich dahintersteckt

Sie könnten sehen...	Was oft tatsächlich passiert
„Herausforderndes Verhalten“, Selbstverletzung, Verweigerung	Zumeist Kommunikation über unerfüllten Bedarf — Schmerz, Angst, Überlastung, verlorene Routine
Belastung nach einem Personal-, Raum- oder Routinenwechsel	Vorhersagbarkeit und Besitz sind Identitäts- und Sicherheitsanker
Meldet keinen Schmerz; plötzlicher Zusammenbruch oder späte Präsentation	Interozeptions -Unterschiede — innere Signale registrieren sich vielleicht erst, wenn schwer
Zurückgezogen, sediert oder „gefestigt“	Mögliches Burnout, Depression oder Über-Medikation — „leise“ ist nicht immer „gesund“
Keine verlässliche Sprache; verlässt sich auf AAC oder eine Begleitperson	Atypische Kommunikation ≠ Kapazitäts- oder Verständnismangel

Versuchen Sie dies

- **Seien Sie ihre Kontinuität** — teilen Sie ein Einseiten-Profil ihrer Interessen, Routinen, sensorischen Bedürfnisse, frühen Warnzeichen und was sie reguliert; halten Sie es aktuell.
- **Bestehen Sie darauf, dass Schmerz und körperliche Ursachen zuerst ausgeschlossen werden** bei jeder neuen Belastung — Verstopfung, Zahnschmerz, Infektion, schlecht sitzende Hilfsmittel sind häufige, verborgene Übeltäter.
- **Schützen Sie Routinen, Objekte und Interessen** — das ist Wohlbefinden, kein Durcheinander; bitten Sie, dass sie über Personalwechsel hinweg bewahrt werden.
- **Drängen Sie auf unterstützte Entscheidungsfindung** und einen individualisierten Kommunikations-/Sensorik-Plan; fordern Sie Autismus-Schulung des Personals.

- **Besuchen Sie und verbinden Sie sich über ihr Interesse**, auf ihre Bedingungen — Sie sind eine Lebensader zu Identität und Zuneigung.

Vermeiden Sie dies

- „Verhaltens“-Etiketten akzeptieren, bevor Schmerz und Überlastung ausgeschlossen sind.
- Festhalten oder Sedierung als Routine-Antworten auf Meltdown/Shutdown werden lassen.
- Besitz oder Routinen „zu ihrem Besten“ entfernen oder von atypischer Kommunikation auf Inkapazität schließen.

Wann weitere Hilfe nötig ist

Behandeln Sie **neue oder eskalierende Belastung** als medizinisches Warnsignal, bis Schmerz, Infektion, Verstopfung, Zahnprobleme und sensorische/umweltbedingte Ursachen ausgeschlossen sind. Beziehen Sie **spezialisierte Autismus-/Lernschwierigkeiten-Teams** und Logopädie (AAC) ein. Fordern Sie für jede Aufnahme einen „**Krankenhaus-/Gesundheitspass**“ und einen ruhigen, schriftlichen Meltdown-/Shutdown-Plan, der Sicherheit über Fixierung stellt.

Geschlechter-Hinweis

Hoch-unterstützte Frauen sind besonders unter-erkannt und unter-versorgt, und ihre Belastung wird noch häufiger fehl-gelesen. Wenden Sie dieselbe Sorgfalt beim Ausschluss von Schmerz und Überlastung an, unabhängig vom Erscheinungsbild oder der Kommunikationsmethode.

Über diesen Leitfaden

KI-gestützt, abgeleitet aus den Forschungsentwürfen dieses Projekts — der Leitfaden für die **Familie** (Teil 5, Pflegeheime & Krankenhäuser) und das **Monotropismus-Dossier**, mit dem Leitfaden für **Praktiker und Gesundheitsfachleute über die Lebensspanne** (Teile 3,5 & 4). Verwendet identitätsfirst-Sprache. **Information — kein medizinischer Rat und kein diagnostisches Werkzeug**. Passen Sie es an die einzelne Person an; Sie kennen sie am besten.

Schlüsselquellen. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Kelly Mahler (2024, Interozeption/Schmerz); Autism Society (2025, Meltdowns/Shutdowns); Leicestershire Partnership NHS Trust (Autism Space). Vollständige Nachweise finden sich in den Quelldossiers.